

SCA · dor torácica e conduta inicial

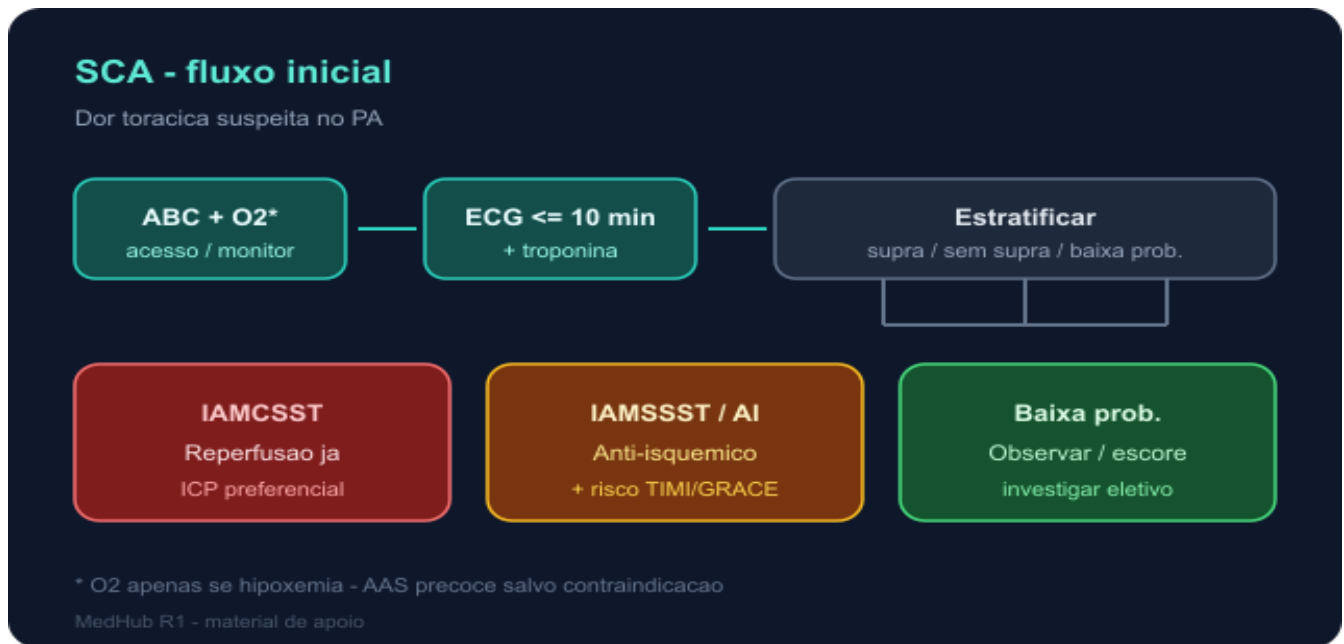
Na prova, a sequência importa: ABC !' ECG rápido !' estratificar !' anti-isquêmicos e decisão de reperfusão.

Pegue o ECG cedo

Lembre - Pegue o ECG cedo

ECG em até 10 minutos na chegada com dor torácica suspeita. Comparar com ECG prévio quando houver.

Fluxo resumido da SCA no pronto atendimento.



Suspeita alta — o que não esquecer

- Dor/opressão retroesternal, irradiação, náusea, sudorese, dispneia
- Equivalente angioso em idosos, diabéticos e mulheres (dispneia, epigastralgia, fadiga)
- Fatores: tabagismo, DM, HAS, dislipidemia, história familiar, DRC

Estratificação prática

Cenário | Achado-chave | Conduta-chave

IAMCSST | Supra de ST / equivalente | Reperusão imediata (ICP preferencial)

IAMSSST / AI | Troponina $\pm$ infra / T invertido | Anti-isquêmico + risco (TIMI/GRACE)

Baixa probabilidade | ECG e troponina negativos | Observação / escore / investigação eletiva

Medidas iniciais (salvo contraindicação)

- AAS 150–300 mg mastigado (dose de ataque)
- Anticoagulação conforme protocolo (enoxaparina/heparina)
- Inibidor P2Y12 conforme estratégia de reperfusão
- Nitrato se dor e PA adequada; morfina se dor refratária
- Oxigênio só se hipoxemia (não rotina em SpO₂ normal)

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Nitrato é contraindicado com uso recente de inibidor de PDE-5 e na suspeita de IAM de ventrículo direito (infra em DII/DIII/aVF com pré-carga dependente).

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1